EPICRISIS MÉDICA

HOSPITAL : HOSPITAL DE SAN CARLOS N° EGRESO : 92844
SERVICIO : MEDICINA HSC
FECHA : 2024-09-15 11:57:00

DATOS DEL PACIENTE:

Nombre	: MARINA MELLADO GONZALEZ			RUN	: 4.841.939-9
F.Nac	: 20-05-1938	Edad	: 86 AÑOS, 3 MESES	Género	: Femenino
Dirección	: TIUQUILEMU			Comuna	: SAN CARLOS
Previsión	: FONASA B	Teléfono	: 65909311		
Fecha Ingreso	: 2024-09-01	Fecha Egreso	: 2024-09-15 11:57:00	Causal	: MEDICA
Condición	: VIVO	Destino	: HOSPITALIZACIÓN DOMICILIARIA	Derivación	:

DIAGNOSTICO(S) INGRESO

1. E87.2-ACIDOSIS.

DIAGNOSTICO(S) EGRESO

1. Acidosis Metabólica con Anion GAP normal, compensada, resuelta
- Deshidratación Moderada
2. LRA KDIGO 1, no oligurica, resuelta
3. Bacteriemia por Staphylococcus epidermidis MR
4. Neumonía Derecha
- Atelectasia subsegmentaria posterior del lóbulo superior derecho.
5. Enfisema pulmonar paraseptal.
- Obs EPOC
6. IAM S/SDST
7. Trastorno HE resuelto
8. Anemia moderada ferropénica
9. Dmt2 ir

DIAGNÓSTICOS CIE10

1. E87.2-ACIDOSIS. (DIAGNÓSTICO PRINCIPAL)

COMENTARIO DE EVOLUCIÓN / COMPLICACIONES

Paciente con antecedentes de DM2 no IR, HTA, previamente semidependiente. Traida por familiar al SU HSC el 01/09/24 por cuadro de 3 días de evolución de compromiso del estado general, inapetencia, vómitos, dolor torácico y disnea. A su llegada hipotensa, taquicardica, taquipneica, saturando 96% amb, afebril. Glasgow 15 puntos. Exs de laboratorio destaca: glicemia 160, crea 1.6 lactato 1.9, PCR 86, uremia 75, ELP 140/4/120, GB 12700, Hb 10.4, PQT 234mil, INR 1.24, Troponina 177->159, albumina 3, DD 9704, GSA pH 7.29, pO2 88, pCO2 19 HCO3 9.4. GSA de control: pH 7.27, pO2 113, pCO2 21 HCO3 10. Anion GAP: 17. Rx de Tórax impresiona foco de condensación a derecha. Se toma HC y administra ceftriaxona. EOC: cuerpos cetónicos (-). Se solicita AngioTC de Tórax: Sin evidencias de TEP. Enfisema pulmonar paraseptal. Atelectasia subsegmentaria posterior del lóbulo superior derecho. Cardiomegalia. Paciente evoluciona con glasgow flutuante de 14 a 10 puntos. Evaluada por UCI, se descarta ingreso a su unidad. Evaluada por Residente UTI, se decide ingreso para manejo y monitorización.

EVOLUCIÓN EN UTI
- HD/CV: Monitorizacion invasiva. DVA para PAM > 65 mmHg. Tromboprofilaxis HNF. Se sospechó IAM SSDST , es traslada a HH pero se desestimó intervención, por lo que mantiene prevención secundaria por IAM, doble antiagregación plaquetaria mas estatinas en dosis altas. Se Inició b bloqueo con buena tolerancia. Reajuste de antiHTA orales según necesidad.
-Gastro: Estudio de anemia evidencia Anemia moderada ferropénica, se solicito Colonoscopia y EDA como parte de su estudio (EDA con gastropatía no causante de anemia), pendiente colonoscopia a

realizar 09/09/24.
- Ventilatorio: FiO2 para saturar 88-92%. Sin O2 hace 24 hrs.
- Infeccioso: Completó 3 días de tratamiento con Ceftriaxona y Azitromicina por imagen de condensacion atelectasica derecha en Radiografía y TC de Tórax. HC 1 (+) Staphylococcus epidermidis MR pero 2 negativo por lo que se interpreta como contaminación por lo que se suspende vancomina. Panel viral negativo. Parámetros inflamatorios a la baja.
- Renal : Vigilancia función renal y ELP. Evitar nefrotoxicos. Se mantiene terapia depletiva.
- Metabólico: HGT por horario y refuerzos SOS.
Dado evolución clínica favorable se decide traslado a medicina para continuar manejo y estudio de anemia.
Paciente estable.
Hemodinamia autosostenida, normotensa, normocárdica. Bien perfundida a distal. Al monitor, RS.
Se mantiene en tratamiento médico por IAM s/SDST, en espera de estudio y resolución de anemia y tolerancia al decúbito para nueva derivación a Hemodinamia. Sin angor sin disnea.
Sin necesidad de transfusión por ahora.
Ventilando espontáneo, desde ayer sin requerimiento de FiO2 adicional. Sin UMA. Sin disnea, con tos productiva.
Afebril, 5° día de tratamiento con Ceftriaxona y azitromicina.
Por cultivo de secrcción bronquia + para S. epidermidis y E. fecalis se inicia Vancomicina la cual hasta hoy lleva 4 días, por estabilidad hemodinámica y corrección del desequilibrio hidroelectrolítico se decide continuar manejo en HODOM hasta cumplir 7 días.

Ex: 15/09 Crea 1,20, pcr 59,3, na 146, k 4,90, cl 120, leu 6,00, hb 8,5, pl 237 mil, procalcitonina 0,08.

PLAN DE MANEJO:

Control en su cesfam, solicitar hora para ajuste de receta crónica y seguimiento de insulinoterapia.

INDICACIONES AL ALTA

1. Reposo relativo
2. Kine respiratoria
3. Regimen bajo en azucar y sal
4. Insulina NPH 10 u am SC despues o junto con el desayuno (educar sobre administración a familiar) (uso permanente)
5. Metformina 850mg 1 con el almuerzo y 1 con la cena (uso permanente)
6. OMEPRAZOL 20 mg vo por 15 días
7. ACIDO ACETILSALICILICO COMPRIMIDO 100 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. (uso permanente)
8. ATORVASTATINA COMPRIMIDO 40 MILIGRAMOS 2 comprimido cada 24 hrs. (uso permanente)
9. CLOPIDROGEL COMPRIMIDO 75 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. (uso permanente)
10. BISOPROLOL COMPRIMIDO 2,5 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 24 hrs. (uso permanente)
11. LOSARTAN POTASICO COMPRIMIDO 50 MILIGRAMOS 1 comprimido cada 12 hrs. (uso permanente)
12. VANCOMICINA AMPOLLA 500 MILÍGRAMOS 2 ampolla cada 24 hrs. por 3 dias via ENDOVENOSA

EXÁMENES Y RESULTADOS

Crea 1,20, pcr 59,3, na 146, k 4,90, cl 120, leu 6,00, hb 8,5, pl 237 mil, procalcitonina 0,08.

PANIQUE PEDRAZA MARIANA ANDREA
MEDICO TRATANTE
24689611-9

JEFE SERVICIO